

Abivajava lapse märkamine esmatasandi tervishoius



Maarja Kärson

laste heaolu osakonna nõunik,
sotsiaalministeerium



Valeria Bida

haldus- ja ärikorralduse BA,
füsioterapeut

ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt on igal lapsel õigus võimalikult heale tervisele ja igakülgsele arengule, samuti õigus olla kaitstud kehalise ning vaimse vägivalga, vigastuste, väärkohtlemise ja hooletusse jätmise eest. Laste väärkohtlemine on aga niivõrd keerukas ja peidetud nähtus, et abivajavat last ära tunda ja olukorda sekkuda ei ole lihtne isegi õppinud tervishoiutöötajal.

Lapse abivajaduse üks peamisi põhjusi on väärkohtlemine. Selleks peetakse lapse vaimset, emotsionaalset, kehalist või seksuaalset väärkohtlemist või lapse hooletusse jätmist. Väärkohtlemist ei ole enamasti võimalik välja selgitada ühe kindla tunnuse põhjal, vaid tuleb panna tähele erinevaid märke. Sageli on ohver kogenud mitut liiki väärkohtlemist.

Emotsionaalne (ka vaimne) väärkohtlemine on lapsele emotsionaalse pingeseisundi tekitamine, mis võib kahjustada lapse tundeelu arengut. Selle alla kuuluvad hirmutamine, ähvardamine, karjumine, söimamine, solvamine, mõnitamine, manipuleerimine jms.

Kehaline väärkohtlemine on vanema või hooldaja tahtlik, mitte kogemata juhtunud füüsilise jõu kasutamine lapse suhtes (sh lapse löömine käe ja/või jalaga, esemega viskamine, raputamine, kägistamine, näpistamine, väänamine ja pigistamine, hammustamine, tõukamine, juustest tirimine, uputamine, põletamine, mürgitamine), mis võib last vigastada ja jätta jälje psüühikale.

Seksuaalne väärkohtlemine tähendab lapse kaasamist seksuaalsesse tegevusse, mille sisu ta täielikult ei mõista, mille suhtes ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis eirab seadustega kehtestatud või sotsiaalseid norme.

Lapse hooletusse jätmine seisneb vanema või hooldaja kohustuste mittetäitmisel lapse kehalise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu eest hoolitsemisel, mis võib kahjustada lapse eakohast arengut ning tervist.¹

Tervishoiutöötaja roll lapse abivajaduse märkamisel

Kuigi abivajavast lapsest peab teatama igäiks, kes sellist last märkab, on lastega iga päev töötavatel spetsialistidel, näiteks õpetajal, treeneril või arstil mõnevõrra suurem võimalus ja seega ka vastutus lapse probleeme märgata ning neile reageerida.

Laste väärkohtlemise märkamises ja sekumises on tähtis osa esmatasandi tervishoiutöötajatel, kes puutuvad ühe ja sama pere lastega kokku korrapäraselt, seda eriti imiku- ja

¹ Vt väärkohtlemise liikide kohta täpsemalt: www.kriminaalpoliitika.ee/perevagivald/laste-vaarkohtlemine-peres.

eelkoolieas, mil lastel on suurim oht langeda väärkohtlemise ohvriks (Caneira ja Myrick 2015). Ameerika Pediaatrie Akadeemia on avaldanud väärkohtlemise teemal poliitikasoovitusi, näidates, et väärkoheldud laste väljaselgitamine ja abistamine on lahutamatu osa esmatasandi tervishoiutöötaja või lastearsti tööst (Flaherty ja Stirling 2010). Eesti Lastearstide Selts märkis 2015. aasta avalikus pöördumises, et lastearstide kohus on olla laste kui enim haavatava ühiskonna osa advokaatideks, märgata laste tervise ohustamist, nende hooletusse jätmist ja väärkohtlemist ning vajaduse korral teavitada lastekaitsetöötajaid ja politseid.

Perearstid märkavad ja diagnoosivad väärkohtlemise tunnuseid vägagi erinevalt.

Hiljuti kinnitas ravijuhendite nõukoda Eestis uue lapse tervise jälgimise juhendi (2019). See on mõeldud eelkõige esmatasandi tervishoiutöötajatele, kes teevad regulaarselt laste tervisekontrolli. Uues juhendis on senisest rohkem rõhku pandud ennetusele ja varajasele märkamisele, sealhulgas lapsevanemate toetamisele. Juhendi kohaselt peaks tervisekontrolli tegija pöörama igal visiidil tähelepanu pere toimetulekule ja sellele, kas vanemad suudavad piisavalt laste eest hoolitseda. Vajaduse korral tuleb kaasata lastekaitse- või sotsiaaltöötaja, kes suunab lapsevanemad vanemlusprogrammi. Ebapiisavad vanemlikud oskused võivad olla laste väärkohtlemise põhjuseks. USAs 2009. aastal korraldatud uuring vanemlusprogrammi Triple P mõju kohta näitas, et teenusega kaetud piirkonnas vähendas vanemlike oskuste arendamine vanemlusprogrammi abil oluliselt laste väärkohtlemise juhtumeid (Prinz jt 2015).

Lapse tervise jälgimise juhendis

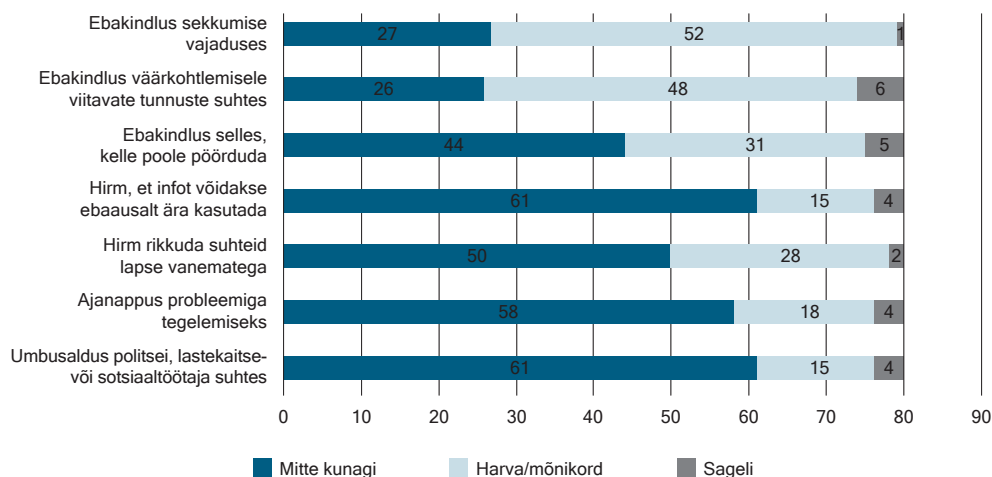
rõhutatakse, et lapsega töötaval isikul, sh arstil on lapse abivajaduse märkamisel ja sellest teavitamisel eriti suur vastutus. Arst või õde ei pea lapse väärkohtlemises isiklikult veendumata või andma sellekohast õiguslikku hinnangut, vaid peaks võimalikust abivajavast lapsest teavitama, kui tekib ka üksnes kahtlus väärkohtlemises. Ei ole täpsustatud, mis olukorras peaks selline kahtlus tekkima, mistõttu peab tervishoiutöötaja toetuma oma professionaalsele kogemusele ja hinnangule.

Spetsialistid ei teata alati oma kahtlustest

Eestis lastega töötavate spetsialistide seas korraldatud uuringust (Soo jt 2009) selgus, et 63% vastanutest ei olnud väärkoheldud lapsest mingil põhjusel teatanud. Kõige sagedamini (45%) oli põhjuseks lapsega töötava isiku ebakindlus probleemi tõsiduse suhtes. Küsitluses osalenud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad tõid välja, et peamiselt saavad nad infot väärkoheldud lastest teiselt lastekaitse- või sotsiaaltöötajalt või kooli personalilt, harvem meditsiinitöötajalt: 13,8% said perearstilt teateid sageli, 51,3% mõnikord ja 35% väga harva või mitte kunagi. Veelgi harvem saadi infot haiglast ja kiirabitöötajalt.

Tervishoiutöötaja võiks lapse väärkohtlemise kahtluse korral pidada nõu kohaliku sotsiaal- või lastekaitsetöötajaga või lasteabi-telefoni konsultandiga. Vajaduse korral saab küsida nõu või edastada teate ka anonüümselt (lastekaitseseaduse § 27 lg 5). Teetamisele ei pea kohe järgnema sotsiaal- või lastekaitsetöötaja sekkumine, kui tervishoiutöötaja on valmis ise asjaolusid selgitama, näiteks lapse ja vanematega rääkima.

Kui tervishoiutöötaja otsustab oma kahtlusest mitte teatada, tuleks tal kindlasti veelkord järele mõelda, kas selle põhjuseks on veendumus, et lapsega on kõik hästi, või tema enese hirmud (nt hirm üle reageerida või hirm



Joonis 1. Laste väärkohtlemisest teatamist takistanud asjaolude esinemissagedus (n=80)

kaotada lapse ja pere usaldus). Konsulteerida võiks ka kolleegiga. Sageli ei saagi lapse väärkohtlemises väga kindel olla enne, kui on lapse ja perega räägitud ning asjaolusid selgitatud. Kui seda tehakse toetavalt ja diskreetselt, ei kahjusta see last ning tema peret ka siis, kui kahtlus ei osutu tõeks. Kui selgub, et last ei ole väärkoheldud, võib tal olla muid muresid, mis saavad tähelepanu ja lahenduse.

Abivajavast lapsest teatamist ei takista ka andmekaitse nõuded, sh Eestile kohalduv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ega isikuandmete kaitse seadus. Seda võiksid lastekaitse võrgustiku liikmed igal võimalusel üksteisele meelde tuletada. Sel teemal on lasteombudsman (2015) koostanud põhjaliku juhendi.

Eesti perearstide ja -õdede kokkupuuted laste väärkohtlemisega

2019. aasta aprillis korraldas artikli üks autoritest, Valeria Bida oma diplomitöö raames küsitluse, et välja selgitada, kuidas Eesti perearstid ja -õed märkavad väärkohtlemise kahtlusega lapsi ning mis raskustega puutuvad spetsialistid kokku väärkohtlemise kahtluse

korral. Perearstidelt ja -õdedelt laekus kokku 80 vastust. See ei ole küll piisav laiaulatuslike üldistuste tegemiseks, kuid näitab siiski peamisi tendentse ning probleeme.

Küsitlusest selgus, et perearstide ja -õdede jaoks on väärkohtlemine igasugune tegevus, mis põhjustab lapsele hirmu või vigastusi, sh lapse peale karjumine, lapse mõnitamine, ignoreerimine, isoleerimine suhtlemisest teiste lastega, perevägivald lapse juuresolekul ja lapse meelitamine osalema seksuaalse sisuga tegevuses. Sagedamini puututakse kokku vaimset/emotsionaalselt väärkoheldud lastega, harvemini seksuaalselt väärkoheldud lastega. Vastustes kajastuvad suured erinevused kokkupuudetes nii vanemliku hoolitsuseta või hooletusse jäetud lastega kui ka vaimset/emotsionaalselt väärkoheldud lastega: kui osa vastanutest kohtab selliseid patsiente enda hinnangul sageli, siis teine osa väga harva või mitte kunagi. Ilmselt on võimatu, et mõne perearsti vastuvõtule ei satu üldse seksuaalselt või vaimset/väärkoheldud lapsi. Pigem on tegu sellega, et arstid ja õed märkavad ning diagnoosivad väärkohtlemise tunnuseid väga erinevalt.

Küsimusele, kuidas seksuaalse lapse väärkohtlemise kahtluse korral, vastas enamik

perearste ja -õdesid, et nad teavitaksid lastekaitse- või sotsiaaltöötajad (72 vastanut, 90%) ning sama palju peaks nõu kolleegiga. Lapsevanematega ja lapsega isiklikult vestleks vastavalt 63 ja 66 vastanut. Lasteabitelefoni helistaks 42 vastanut (52%). See viitab, et lasteabitelefoni teenuse kohta oleks vaja jagada rohkem teavet. Samas võib seda teenust asendada tervishoiutöötaja hea kontakt kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistiga.

Ankeedis küsiti ka seda, mis põhjustel on vastaja jätnud väärkoheldud lapsest teatamata (vt joonis 1). Mitteteatamise peamiseks põhjusteks on ebakindlus sekkumise vajaduses ning vähesed teadmised väärkohtlemisele

viitavate tunnuste kohta. Ligi veerand vastanutest jätsid teatamata, sest ei uskunud, et sellest võiks lapsele abi olla. Võrgustikukoostöö sujuvust väärkohtlemisest teatamise korral see uurimus ei käsitlenud.

Tervishoiutöötajate sage kokkupuude laste vigastuste ja haigestumistega paneb proovile nende teadmised laste väärkohtlemise tunnustest ning oskuse tekkivast kahtlusest teatada. Enamasti ei ole vägivallal teisi tunnistajaid kui ohver ja toimepanija; laps ei tarvitse hirmu tõttu sellest rääkida või ta ei teadvusta, et talle tekitatakse kahju; vigastused ei ole alati spetsiifilised. Oluline on osata eristada väärkohtlemisest põhjustatud vigastust olmetraumast

Abimaterjalid väärkohtlemise juhtumite tuvastamiseks

Eestis ei ole eraldi juhendmaterjali tervishoiutöötajatele lapse väärkohtlemise juhtumite tuvastamise ja käsitlemise kohta. „Seksuaalvägivalla ohvrite abistamise juhend meedikutele” (Laanpere ja Part 2016) ei käsitle eelpuberteedieas lapsi, kuid annab siiski olulist teavet pere- ja lastearstile. Väärkohtlemise kindlakstegemisel ja sellesse sekkumisel võivad tervishoiutöötajale abiks olla järgmised üldisemad või teiste valdkondade spetsialistidele suunatud juhendmaterjalid:

- Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis (Järv-Mändoja jt 2011)
- Juhendmaterjal perevägivalla vähendamiseks ja ennetamiseks (Linno jt 2011)
- Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias (Järv-Mändoja jt 2014)
- Laste ja noorte seksuaalkäitumise murebaromeeter (Justiitsministeerium 2015)
- Lapse heaolu hindamise käsiraamat (Sotsiaalkindlustusamet 2017)
- Lapse käsitlemise käsiraamat (Liivamägi-Hitrov ja Kask 2016).

Teistest riikidest leiab näiteid just tervishoiutöötajatele mõeldud juhenditest laste väärkohtlemise teemal. Soomes on olemas ravijuhis „Tõhusad meetodid laste väärkohtlemise äratundmiseks sotsiaal- ja tervishoiuteenuste valdkonnas” (Hotus 2015) ning Ühendkuningriigis NICE (2009) ravijuhend „Laste väärkohtlemine: millal kahtlustada alla 18aastase lapse väärkohtlemist”. Juhendmaterjale on koostanud ka Maailma Terviseorganisatsioon, nt juhend meditsiinilise ja õigusliku abi andmiseks seksuaalvägivalla ohvritele (WHO 2003). Sel aastal peaks WHOlt ilmuma ka laiapõhjaline juhend laste väärkohtlemise juhtumite käsitlemiseks tervishoius.

Kõik need materjalid on abiks ka Eestis tervishoiutöötajatele suunatud praktilise juhendi koostamisel, et suurendada ja ühtlustada spetsialistide teadmisi laste väärkohtlemise teemal ning pakkuda tuge lapse paremaks abistamiseks.

(nt vastavate algoritmide abil²) ning vaadelda juhtumit tervikuna, muu hulgas analüüsisid nii vanemate kui ka laste käitumist.

Andmekaitseõuded ei takista abivajavast lapsest teatamist.

Üle 80% uuringus osalenud tervishoiutöötajatest tunnistas, et vajab laste väärkohtlemise teemal lisateadmisi ja praktilist juhendit, mis hõlmaks võimalikule laste väärkohtlemisele viitavaid tunnuseid, kahtlusest teatamise käitumisjuhiseid ning nõuandeid, kuidas suhelda väärkohtlemise kahtlusega lapsega ja tema vanematega. See toetab kavatsust välja töötada asjaomane juhend tervishoiutöötajate jaoks.

Kokkuvõtteks

Esmatasandi tervishoiutöötajatel on tähtis osa laste väärkohtlemise juhtumite märkamisel ja nendest teatamisel. Väärkohtlemisel ei ole sageli eriomaseid meditsiinilisi tunnuseid ja

seetõttu on määrava tähtsusega spetsialistide teadmised laste väärkohtlemise põhjustest, ohuteguritest, liikidest ja võimalikest tunnustest, et osata tähele panna ja tõlgendada kahtlasi märke. Perearstide ja -õdede küsitlus kinnitas vajadust juhendmaterjali järele, mis aitaks tervishoiutöötajatel ära tunda võimalikku lapse väärkohtlemist ning pakuks praktilisi juhiseid juhtumiga tegelemisel. Sotsiaalministeeriumil on kavas alata sellise juhendmaterjali koostamine koostöös tervishoiutöötajate jt lastega töötavate spetsialistidega.

Väärkohtlemise juhtumite lahendamiseks on vaja ka tõhusat võrgustikutööd. Tervishoiutöötajal peaks olema lastekaitse spetsialistiga hea kontakt ja koostöö, mida saab edendada nt regulaarsete kohtumiste või võrgustiku ümarlaua abil. Oluline on kokku leppida omavahelise infovahetuse alused, mis hõlmab ka perearstile või -õele tagasiside andmist juhtumi lahendamise kohta, et tervishoiusüsteem saaks last ja peret edaspidi paremini toetada. **S**

Viidatud allikad

- Caneira, L., Myrick, K. M.** (2015). Diagnosing Child Abuse: The Role of the Nurse Practitioner. *The Journal for Nurse Practitioners*. 11(6), 640–646.
- Flaherty, E. G., Stirling, Jr, J.** (2010). Clinical report – The pediatrician's role in child maltreatment prevention. *Pediatrics*, 126 (4). doi:10.1542/peds.2010-2087.
- Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)** (2015). Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. www.hotus.fi/lasten-kaltoinkohtelun-tunnistamisen-tehokkaat-menetelmat-sosiaali-ja-terveydenhuollossa-hoitosuositus (15.08.2019).
- Justiitsministeerium** (2015). Murebaromeeter. www.kriminaalpoliitika.ee/laste-ja-noorte-seksuaalkaitumise-murebaromeeter (15.08.2019).
- Järv-Mändoja, K., Käesel, K., Pill, E., Riis, M.** (2011). Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Järv-Mändoja, K., Riis, M., Käesel, K., Pill, E.** (2014). Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal. Tallinn: Tervise Arengu Instituut.
- Eesti Lastearstide Selts** (2015). Eesti lastearstide pöördumine Eesti ühiskonna poole. www.elselts.ee/els/images/materjal/2015/2015_eeesti_lastearstide_poordumine.pdf (15.08.2019).
- Laanpere, M., Part, K.** (2016). Seksuaalvägivalda ohvrite abistamise juhend meedikutele. Tartu: Eesti Seksuaaltervise Liit.

² Nt NICE (2009) ravijuhend annab soovitusi, milliste vigastuste ja muude asjaolude esinemisel või koosesinemisel tuleks kahtlustada väärkohtlemist.

Lapse tervise jälgimise juhend (2019).

www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/130/lapse-tervise-jalgimise-juhend (15.08.2019).

Lasteombudsman (2015). Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend. Tallinn: Õiguskantsleri Kantslei.

Liivamägi-Hitrov, A., Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn: Justiitsministeerium.

www.kriminaalpoliitika.ee/lapsekysitlemisekasiraamat (15.08.2019).

Linno, M., Soo, K., Strömpl, J. (2011). Juhendmaterjal perevähivalla vähendamiseks ja ennetamiseks. Tallinn: Justiitsministeerium.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2009). Child maltreatment: when to suspect maltreatment in under 18s. www.nice.org.uk/guidance/cg89 (15.08.2019).

Prinz, R. J., Sanders, M. R., Shapiro, C. J., Whitaker, D. J., Lutzker, J. R. (2015). Population-based prevention of child maltreatment: The U.S. Triple P system population trial. *Prevention Science*, 10(1), 1–12.

Soo, K., Ilves, K., Strömpl, J. (2009). Laste väärkohtlemise juhtumitest teavitamine ja võrgustikutöö. Lõppraport. Tartu: Tartu Ülikool.

Sotsiaalkindlustusamet (2017). Lapse heaolu hindamise käsiraamat.

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/lapse_heaolu_hindamise_kasiraamat.pdf (15.08.2019).

World Health Organization (WHO) (2003) Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Genf: WHO.